Tratamiento de las enfermedades infecciosas

FISIOPATOLOGIA · Clase 28 · factor enfermo, factor agente, dosis, vía, duración y asociación de antibióticos

1 · DOS FACTORES Y FACTOR ENFERMO

F1
Antes de dar un antibiótico
se evalúan dos factores: el enfermo y el agente

primero se evalúa al

F11
Factor enfermo
alergia, función renal y hepática, inmunidad, vía oral, gravedad, edad y sexo

con alergia previa, se cambia de familia

F22
Alergia a penicilina
se cambia de familia; no ampicilina ni amoxicilina; cefalosporinas con precaución (cruce de unos 10 %)

si el órgano falla, se acumula

F23
Riñón o hígado enfermos
el aminoglucósido se acumula: nefrotoxicidad y ototoxicidad; se ajustan dosis e intervalo

si hay embarazo, se evitan

2 · EMBARAZO Y CASO DE LA GESTANTE

F7
Embarazo
prohibidos: aminoglucósidos (oído fetal), tetraciclinas (dientes y huesos) y ciprofloxacino (cartílago)

y también se evalúa al

se prefieren los

F20
Seguros en el embarazo
penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas y nitrofurantoína

en la gestante con ITU se elige

F6
Gestante con ITU por E. coli resistente a ampicilina
el docente elige nitrofurantoína

3 · FACTOR AGENTE

F12
Factor agente
identificación y sensibilidad, abuso previo de antibióticos, precio del fármaco y salario

se identifica con

F12 · F15
Cultivo y antibiograma
guían la elección; neumococo: penicilina primero y macrólido de segunda opción

incluye el

F19
Precio y salario
si el paciente no puede pagarlo, no completa el tratamiento y aparece resistencia

mientras tarda, a veces se da

F21
Tratamiento empírico
solo con sospecha bacteriana razonable y paciente que no puede esperar (sepsis, meningitis, neutropenia febril)

si hay que combinar, aplica la regla de

según tolerancia y gravedad se elige la

4 · VÍA Y DOSIS

F8 · F17
Vía de administración
leve: oral; vómitos, bacteriemia o grave: IV/IM; pasa a oral con mejoría al 3.º-4.º día

si no mejora, se reevalúa en el

Sin mejoría al 3.º-4.º día
se reevalúa el esquema: nuevo cultivo, ajuste de dosis o cambio de antibiótico

después se ajusta la

F13
Dosis
varía con edad, peso, sexo, función hepática y renal y gravedad: no hay dosis universal

luego se fija la

5 · DURACIÓN

F9
Duración
cuanto más larga, más toxicidad, disbiosis y resistencia

en la faringitis estreptocócica dura

F3 · F14
Faringitis estreptocócica
penicilina 10 días para prevenir la fiebre reumática

con viridans y endocarditis dura

F4 · F14
Estreptococo viridans
4 semanas por riesgo de endocarditis: la vegetación valvular se penetra mal

en la tifoidea dura

F5 · F14
Fiebre tifoidea
Salmonella typhi: 14 días

6 · ASOCIAR ANTIBIÓTICOS

Asociar antibióticos
sin identificar el germen no se recomienda; mientras llega el cultivo, esquema empírico

incluye fármacos

y también fármacos

Bactericidas
penicilina, ampicilina, cefalosporinas, aminoglucósidos y ciprofloxacino: matan

al juntarse dos, dan

F16
Sinergia
bactericida + bactericida (penicilina + aminoglucósido) rompe la bacteria

Bacteriostáticos
tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol y sulfamidas: frenan la división

al juntarse con un bactericida, dan

F2
Antagonismo
el bactericida necesita bacterias en división y el bacteriostático las frena

si se alarga sin motivo, favorece la

7 · MAL USO: VIRUS Y RESISTENCIA

descarta primero si es

F10 · F18
Infección viral
fiebre de 2 días con rinorrea y mialgias: el antibiótico no la toca

se maneja bien con

F18
Vigilar y dar tratamiento sintomático
sin antibiótico

tratado con antibiótico solo selecciona

Resistencia bacteriana
el antibiótico innecesario o prolongado solo selecciona gérmenes resistentes

concepto · ejemplo · mecanismo · diagnóstico · desenlace · causa · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 31 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)